

Partiel Soins Infirmiers en Chirurgie — Abidjan P32

SOINS INFIRMIERS EN PATHOLOGIE CHIRURGICALE

ANNÉE ACADÉMIQUE : 2022-2023

LICENCE 2 : INFIRMIERS (ERES)

Date : AVRIL 2024 VERSION B Durée : 01 Heure

I. QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE (QCM)

- Cocher la ou les bonnes réponses

– Une réponse juste = 1 pt

– Aucune réponse = 0 pt

'V CAS CLINIQUE 1 : C'est une inflammation de la cavité péritonéale habituellement causée par une infection bactérienne.

1. De quoi s'agit-il ? (Choisir la bonne réponse)

A – Appendicite aiguë

B – Occlusion intestinale aiguë

C – Péritonite

2. Le malade étant couché, des caractères essentiels permettent d'affirmer qu'il s'agit d'une hernie non compliquée ; Lesquels ? (Choisir les 02 bonnes réponses)

A – Réductibilité

B – Irréductibilité

C – Non impulsive à la toux

D – Impulsion à la toux

E – Pas de tympanisme (intestin).

3. Toute hernie de la paroi abdomen est constituée par un élément anatomique par lequel le viscère hernié s'engage. (Choisir la bonne réponse)

A – L'orifice herniaire

B – Le contenu

C – Les enveloppes.

4. En cas d'occlusion par appendicite aiguë, il faut : (Choisir la bonne réponse)

A – Faire un traitement antibiotique

B – Intervenir chirurgicalement

C – Faire une réanimation.

5. La principale complication de la hernie est : (Choisir la bonne réponse)

A – Le plastron appendiculaire

B – L'hydrocèle

C – L'étranglement herniaire

D – La hernie inguino-scrotale.

6. L'un des buts du traitement de la hernie est de :

A – Éviter les récives.

B – Traiter le contenu du sac herniaire.

C – Faire une réfection pariétale par raphie.

7. Indiquer deux (02) examens complémentaires à faire dans le bilan préopératoire chez le patient

qui souffre d'une telle pathologie parmi ceux cités ci-dessous :

A – NFS

B – Radiographie pulmonaire

C – Hémoculture

D – Protidies totaux

E – TP – TCK

8. Deux (02) signes radiologiques dont l'un mettant en évidence le signe essentiel qui affirme l'occlusion et l'autre réalisé en urgence sont à indiquer parmi ceux cités ci-dessous.

A – L'abdomen sans préparation

B – L'échographie abdominale.

C – La coelioscopie

D – Le lavement baryté

E – La tomodensitométrie abdominale.

9. La radiographie en cas de luxation antéro-interne de l'épaule consiste à réaliser : (Choisir la bonne réponse)

A – Un cliché de face de l'épaule

B – Un cliché de profil transthoracique

C – Les deux (02) à la fois.

10. Le premier symptôme de l'adénome de la prostate parmi ceux cités ci-dessous est :

A – La pollakiurie nocturne et ou diurne

B – L'incontinence urinaire

C – La dysurie

D – La miction retardée.

11. Cet examen radiologique permet de mesurer le résidu post-mictionnel, surveiller le retentissement sur le haut appareil, de même que la dilatation des cavités et enfin apprécier le poids, le volume de l'adénome de la prostate ; Lequel ?

A – L'urétro cystographie rétrograde (UCR)

B – L'échographie rénale, vésicale et prostatique.

C – L'urographie intraveineuse (UIV).

12. La pulpectomie est l'ablation : (Choisir la bonne réponse)

A – Du prépuce

B – De la prostate

C – Des testicules.

13. L'ablation de l'adénome provoque : (Choisir la bonne réponse)

A – Une baisse de la libido

B – Une éjaculation rétrograde

C – Une virilité.

14. La rétention aiguë est une : (Choisir la bonne réponse)

A – Impossibilité de vider totalement la vessie

B – Impossibilité brutale et totale d'émettre des urines

C – Impossibilité brutale et totale de vider totalement et de vider totalement la vessie.

15. Indiquer deux (02) causes des rétentions aiguës ou chroniques d'urines parmi celles citées ci-dessous :

- A – Cancer du rein
- B – Phimosi serré
- C – Tumeur de la vessie.
- D – Cancer de la prostate évolué
- E – Inflammation des bassinette.

'V CAS CLINIQUE 2 : Un patient de 57 ans, 70 kg est reçu aux urgences chirurgicales pour brûlure par électrocution. L'examen clinique pratiqué par l'interne de garde notifie les lésions suivantes :

- La moitié de la tête
- Les deux avant-bras
- La main gauche

Table de LUND et BROWDER – Adulte :

Tête : 7 %

Un avant-bras : 3 %

Une main : 2,5 %

16. Selon la table de LUND et BROWDER, la surface corporelle brûlée est :

- A – 12,5 %
- B – 15,5 %
- C – 12 %
- D – 15 %

17. Le premier jour de la prise en charge du patient, le chirurgien décide de réhydrater. La quantité de soluté indispensable selon la règle de BAXTER est :

- A – 1680
- B – 3360
- C – 3500
- D – 1750

18. Les circonstances de survenue d'une brûlure font état : (Choisir les 02 bonnes réponses)

- A – De la survenue de brûlure
- B – De la compression vasculaire
- C – Du type de produit
- D – De l'atteinte des orifices naturels
- E – Du positionnement de la victime par rapport au foyer.

19. Les complications suivantes sont des complications secondaires des fractures excepté une, laquelle ?

- A – Retard de consolidation
- B – Déplacements secondaires locaux
- C – Lésions nerveuses.

20. Le délai de consolidation de la fracture des deux (02) os de l'avant-bras est de :

- A – 4 Semaines
- B – 8 à 12 Semaines
- C – 6 à 8 Semaines

21. Avec quelle pathologie peut-on faire le diagnostic différentiel de l'appendicite aiguë devant la douleur dans les affections chirurgicales :

- A – La cholécystite aiguë

B – La pyélonéphrite droite

C – L'iléite terminale.

22. Deux (02) causes plus courantes de la péritonite :

A – Lithiase rénale

B – Calculs biliaires

C – Appendicite rompue

D – Abscès du Douglas

E – Cholécystite aiguë.

23. L'appendice a une position variable : (Choisir la bonne réponse)

A – Latérocaecale

B – Sus-hépatique

C – Sus-splénique.

24. L'occlusion intestinale aiguë est définie par un signe majeur, lequel ?

A – La douleur abdominale

B – Les vomissements

C – L'arrêt des matières et des gaz

D – Le météorisme abdominal.

25. Deux (02) signes en faveur de la phase primaire du choc ou pré-choc :

A – Tachycardie

B – Pâleur extrême

C – Pouls accéléré, imprenable

D – Instabilité de la tension artérielle

E – Cyanose des extrémités, marbrures des membres.

26. Aux urgences médicales, lors de votre garde vous recevez M. Yao la NFS demandée par le médecin révèle une anémie sévère. Il prescrit alors une poche de concentré érythrocytaire à transfuser en 2 heures au débit de 60 gouttes/min. Calculez le volume de sang transfusé. Indiquez votre résultat parmi ces réponses :

A – 620 ml

B – 480 ml

C – 520 ml

D – 720 ml

27. Indiquer parmi ces propositions deux éléments pouvant être mis en évidence par l'ASP en cas d'occlusion

A – Gargouillement

B – Silence abdominal

C – Niveau hydro-aérique

D – Matité

E – Ballonnement abdominal

F – Signe de l'occlusion

28. Ces événements se succèdent lors d'une brûlure. Classer les par ordre chronologique :1.

Exsudation plasmatique2. Anoxie tissulaire3. Hypovolémie4. Trouble de la perméabilité capillaireIndiquer votre classification parmi ces propositions

A – 1-2-3-4

B – 4-3-2-1

C – 1-4-3-2

D – 4-1-3-2

29. Relever parmi ces propositions trois localisations de gravité d'une brûlure

A – Les parties génitales

B – Profondeur

C – La surface corporelle brûlée

D – Les extrémités

E – Le terrain

F – Les plis de flexion

Vous êtes infirmier au centre de santé rural de NAHIO, M. KOFFI, 55 ans, vous arrive à 3 h 30 du matin pour impossibilité brutale et totale d'uriner.

30. A quelle pathologie-pensez-vous ?

A – Rétention urinaire aiguë

B – Adénome de la prostate

C – Rétention urinaire chronique

31. Un signe fonctionnel parmi ceux indiqués ci-dessous vous rassure pour le diagnostic posé, lequel ?

A – Impossibilité d'uriner

B – Douleur sous-pubienne plus ou moins intense à la palpation

C – Globe vésical

32. La pose de la sonde urinaire se fait dans les cas suivants, sauf deux (02) ; lesquels ?

A – Rétention d'urines

B – Douleur sus-pubienne

C – Infection urinaire

D – Hypertrophie bénigne de la prostate

E – Incontinence urinaire

II. QUESTIONS À CHOIX DOUBLE (QCD)

• Choisir A = VRAI, B = FAUX

– Une réponse juste = + 0,50 pt

– Aucune réponse = 0 pt

33. Faire les examens de laboratoire et les radiographies font partie de l'examen du polytraumatisé.

A – VRAI

B – FAUX

34. En cas d'appendicite aiguë, l'ASP (abdomen sans préparation) montre une image radio-opaque qui signe la présence de stercolithe.

A – VRAI

B – FAUX

35. Seule la radiographie permet de confirmer le diagnostic et de préciser le type de fracture.

A – VRAI

B – FAUX

36. Lorsque la peau est lésée par un fragment osseux il s'agit d'une fracture ouverte véritable.

A – VRAI

B – FAUX

37. En cas d'encombrement bronchique il y a dyspnée avec pneumo-médiastin à la radiographie du thorax.

A – VRAI

B – FAUX

38. Le déplacement transversal est encore appelé déplacement en baïonnette.

A – VRAI

B – FAUX

39. La branche de la médecine qui étudie les maladies infectieuses est l'infectiologie.

A – VRAI

B – FAUX

40. L'asepsie en chirurgie est l'absence de tout germe microbien ou de tout élément susceptible de provoquer la putréfaction ou l'infection.

A – VRAI

B – FAUX

41. Dans la surveillance d'un traumatisé une tachycardie et une hypotension évoquent un état de choc.

A – VRAI

B – FAUX

42. La précipitation est un geste salvateur dans la conduite à tenir auprès d'un traumatisé des voies publiques.

A – VRAI

B – FAUX

43. Dans l'accueil des traumatisés, les victimes sont déplacées en bloc et installées sur un plan souple.

A – VRAI

B – FAUX

44. Lorsqu'il y a fracture isolée ou étagée de côte, le sujet présente une voix cassée.

A – VRAI

B – FAUX

45. En cas d'hémothorax, on note une hyper sonorité.

A – VRAI

B – FAUX

46. La rougeur est le premier signe qui définit l'inflammation.

A – VRAI

B – FAUX

47. Le cliché de face de l'épaule permet de poser le diagnostic positif de la luxation.

A – VRAI

B – FAUX

48. En cas de fracture du Fémur (diaphyse) il faut faire systématiquement la radiographie de face du bassin et la radiographie de face et de profil du genou.

A – VRAI

B – FAUX

49. L'os cède en un point faible selon un trait volontaire au cours du choc direct.

A – VRAI

B – FAUX

50. La déformation est un signe physique de la fracture.

A – VRAI

B – FAUX

51. La réduction est un signe physique de la fracture.

A – VRAI

B – FAUX

52. Le choc opératoire est une variété de choc traumatique.

A – VRAI

B – FAUX

Version B